

株式会社サンプル 2026年度 集団分析結果

対象企業：株式会社サンプル（55名・3部署） / 集計範囲：全部門 / 実施者確認済みの結果のみを集計

確定件数

52名

実施者が確認を終えた受検者数

高ストレス該当

5名

だれかが該当したかは含まれません

総合健康リスク（全体）

109

全国平均＝100／120を超えると要注意

SPQ 平均損失率（全社）

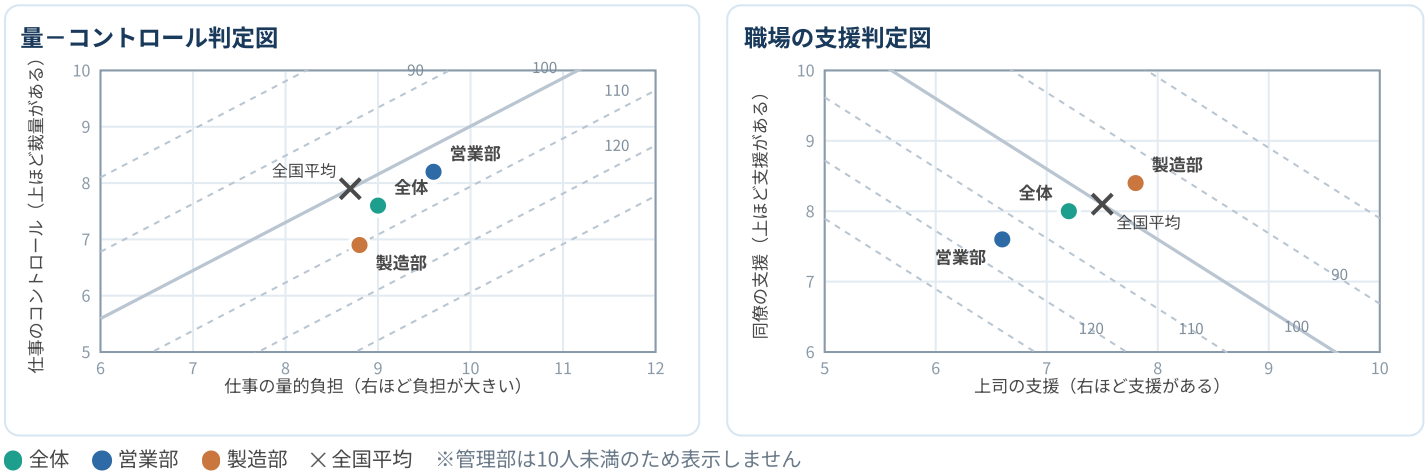
23.8%

全国平均22.5%（50人以上の会社のみ表示）

1. 部署別 高ストレス者の状況

部署	確定件数	高ストレス該当	割合
全体	52名	5名	9.6%
営業部	21名	2名	9.5%
製造部	24名	3名	12.5%
管理部	受検10人未満のため本表から除外（個人特定防止）		

2. 仕事のストレス判定図 斜めの線は健康リスク（太線＝全国平均100）。120超は健康影響が生じている可能性あり



3. 健康リスク 4. 4尺度の比較 各尺度3～12点。（）内は全国平均との差、赤字＝望ましくない側

集団	人数	量的負担 全国8.7	コントロール 全国7.9	上司の支援 全国7.5	同僚の支援 全国8.1	リスクA (量・裁量)	リスクB (支援)	総合
全体	52	9.0 (+0.3)	7.6 (−0.3)	7.2 (−0.3)	8.0 (−0.1)	105	104	109
営業部	21	9.6 (+0.9)	8.2 (+0.3)	6.6 (−0.9)	7.6 (−0.5)	104	115	119
製造部	24	8.8 (+0.1)	6.9 (−1.0)	7.8 (+0.3)	8.4 (+0.3)	110	94	104

5. プレゼンティーズム（SPQ） 損失率＝100－回答値。大きいほど、体調によって発揮できなかった仕事の割合が大きい

集団	回答者	平均損失率	全国平均との比較
全社	50名	23.8%	全国平均22.5%より 1.3ポイント高い
営業部	20名	25.1%	2.6ポイント高い
製造部	23名	22.9%	ほぼ全国平均

保健室からの読み取り（報告会でお伝える内容の例）

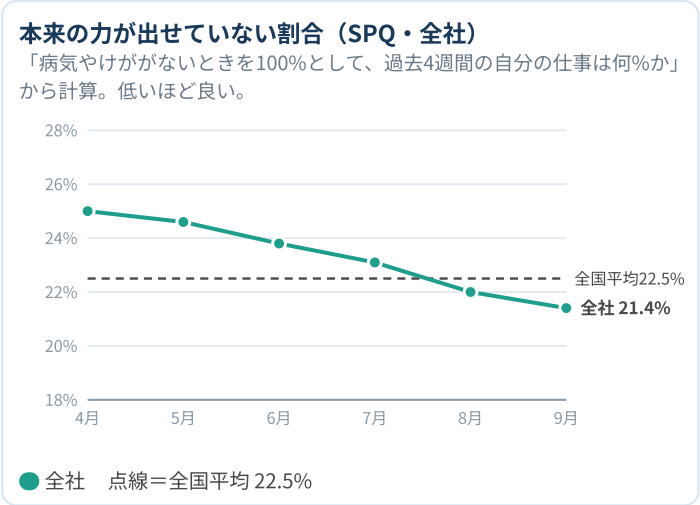
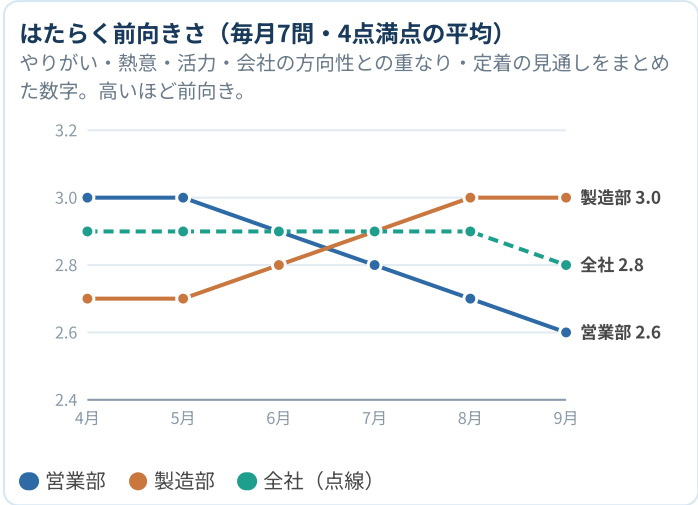
● 営業部：総合健康リスク119で、要注意の120に近い状態です。主な原因は上司・同僚からの支援の少なさと、SPQの損失も全国平均より高めです。→週1回の1on1など「相談のきっかけ」づくりをご提案します。

● 製造部：支援は十分ですが、進め方を自分で決めるににくい状態です。→段取りを現場で決められる範囲を広げることをご提案します。

※ 1～5は、実際のシステムが出力する集団分析報告書と同じ項目です。判定図は男女を区別せず男性用判定図を使用しています（実施マニュアル準拠）。「保健室からの読み取り」は、報告書をもとに保健室がお伝える内容の例です。

株式会社サンプル 2026年4月～9月の変化

年1回の結果だけでは見えない「上がり下がり」を、毎月の線で追いかけます



毎週の体調確認（体温+4問） 4月～9月の合計

回答率（毎週の平均）

92%

未回答の方には自動で催促メール

保健室へのお知らせ

6件

「少し気になる」「やや寝不足」など。保健室が確認し、必要な方へ連絡

「上司・総務に一報を」の案内

2件

「不調」「勤務が難しい」または37.5℃以上。ご本人から申し出があった事実のみ会社へ

この半年で見えたこと

部署	変化	保健室の読み取りと、次の一手
営業部	前向きさが 3.0 → 2.6 に少しずつ下がっている	法定チェックで出た「支援の少なさ」と同じ方向の動き。年1回の結果を待たずに、上司との1on1の時間づくりを早めにご提案します。
製造部	前向きさが 2.7 → 3.0 に上がっている	7月に始めた段取りの見直しのあとから上向き。取り組みの効果が数字で確かめられます。
全社	SPQの損失が 25.0% → 21.4%（全国平均を下回った）	本来の力が出せている人が増えています。面談・相談の利用と合わせて、続けて見ていきます。

年1回のチェックとのちがい

- 年1回では「6月の時点」しか分かりません。毎月見ると、**下がり始めの段階**で手を打てます。
- 取り組みのあとに数字が動いたかで、**効果を確認めながら**進められます。

会社にお渡しする範囲

- 部署・全社の集計と変化のみ。**個人の回答はお渡ししません。**
- 10人未満の部署は、集団分析と同じく表示しません。

※ 定期チェックは、年1回の法定ストレスチェックとは別の、保健室独自のチェックです。
※ SPQは東京大学が開発した1問版の調査票です。